

· 基层园地 ·

2017 年欧洲生殖器疱疹临床管理指南解读

柯吴坚, 杨斌

摘要 生殖器疱疹是当今最常见的性传播感染之一。早期识别和及时治疗是减少疱疹持续时间或避免严重并发症(如尿潴留、脑膜炎等)的关键。然而在生殖器疱疹的诊治中存在诸多问题,困扰临床工作者。为此英国南安普敦医学系 Patel 教授领衔数十位欧洲各专业领域顶尖教授,于 2017 年 12 月在国际性病和艾滋病杂志上联合发布《2017 年欧洲生殖器疱疹治疗指南》。该指南基于循证医学证据,对生殖器疱疹的诊断、治疗、随访以及减少疱疹传播等方面提供解决策略。

关键词 生殖器疱疹; 诊断; 治疗; 欧洲指南

中图分类号 R 752.1 **文献标识码** A **文章编号** 1001-7089(2019)01-0107-08
DOI 10.13735/j. ejdv. 1001-7089. 201805152

Interpretation of 2017 European Guidelines for the Management of Genital Herpes

KE Wujian, YANG Bin

(STD Department, Dermatology Hospital of Southern Medical University, Guangzhou 510091, China)

Corresponding author YANG Bin, E-mail: yangbin101@hotmail.com

Abstract Genital herpes is one of the commonest sexually transmitted infections worldwide. Early recognition and timely treatment are the key to reduce the duration of illness or avoid severe complications, such as urinary retention or meningism. However, there are still problems in the diagnosis and treatment of genital herpes. Therefore, on December 2017, Dr. Patel from Department of Genitourinary Medicine of Southampton led top professors specialized in various fields of sexually transmitted diseases in Europe to issue the latest genital herpes guideline in the International Journal of STD & AIDS. Based on evidence-based medicine, this guide provides the solution to the diagnosis, treatment, follow-up of genital herpes, and reduction of herpes transmission.

Key words Genital herpes; Diagnosis; Treatment; European guideline

疱疹感染指面部或生殖器部位感染 1 型单纯疱疹病毒(HSV-1)或 2 型单纯疱疹病毒(HSV-2),并导致感染部位出现临床症状。HSV 与其他急性病毒性感染一样,也可能出现全身症状。只有三分之一的生殖器疱疹患者在首次感染时出现可识别的典

型临床特征。感染后,病毒潜伏在局部感觉神经节,周期性复发引起临床表现或呈具有感染性的无症状病毒脱落。生殖器疱疹可由 HSV-1 或 HSV-2 引起,然而前者是引起口唇部位单纯疱疹的常见原因。HSV-1 和 HSV-2 可引起相似的临床症状和体征。

作者单位 南方医科大学皮肤病医院性病科,广东 广州 510091

通讯作者 杨斌, E-mail: yangbin101@hotmail.com

网络首发时间 2018-12-01 09:02 **网络首发地址** <http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1197.R.20181201.09:02.002.html>
<http://pfbxzz.paperopen.com>

当感染部位位于生殖器区域时,HSV-2 复发频率比 HSV-1 更多。皮损复发或具有前驱症状时,疱疹传播风险最大。应建议患者在此期间避免性接触。由于存在无症状病毒脱落,因此 HSV 在没有皮损时仍具有传染性。虽然安全套预防疱疹传播的确切效能目前仍未被正式评估,但现有的数据显示持续使用安全套可减少男对女 HSV 的传播,因此目前建议坚持使用安全套来防止 HSV 传播。

1 诊断注意事项

典型生殖器疱疹最初的临床表现是呈现丘疹性皮损,然后进展为水疱和溃疡,并可伴有局部淋巴结炎。复发性生殖器疱疹发作前常出现前驱症状。生殖器疱疹临床表现在不同患者存在明显的个体差异,大部分患者会出现非典型症状,因此容易与其他生殖器皮肤病相混淆,应避免单纯依靠临床表现对非典型症状患者进行诊断。

1.1 病毒学检测 所有疑似生殖器疱疹的患者都建议进行实验室确诊,建议采用直接检测病毒的检测手段。应从病变基底部取材,如用针头或刀片祛除水疱表皮后取材。在疾病早期(如疱疹首次发作或再次复发时)进行病毒检测成功率更高,如果患者临床表现不典型,应尽快取材进行实验室确诊。推荐对所有首次感染生殖器疱疹者进行 HSV 分型以利于后期的临床指导和治疗。由于 HSV 是间歇性脱落,因此不建议对无症状患者采用该检测方法作为常规诊断方法。与细胞培养相比,HSV DNA 检测的敏感性和特异性更高,可将皮肤黏附部位的 HSV 检测率提高 11%~71%,因此目前被认为是疱疹诊断金标准,并作为首选的检测方法。实时荧光定量 PCR 法与病毒培养方法相比,不需要严格的样品贮存和运输条件;与传统 PCR 法相比,可快速对 HSV 进行检测和分型,且污染风险更低。在一些特殊的情况下可能需要用细胞培养来明确抗病毒药物的敏感性,以及培养出足够的病毒用于 HSV 传播研究。除非在资源极为有限的地区,目前不再推荐病毒抗原检测方法(包括直接免疫荧光检测、酶联免疫分析、Tzanck 检测和巴氏染色)。

1.2 HSV 型特异性血液学检测 不推荐在无症状患者中采用血液学检测,但在以下群体中可能是有用的:①对病毒检测阴性的复发或非典型生殖器疱疹患者,采用 HSV-2 抗体检测将有助于疱疹的诊

断。由于 HSV-1 抗体阳性无法区分生殖器或口咽部疱疹感染,同时 HSV-1 并不是复发性生殖器疱疹患者感染的常见原因,因此对 HSV-2 IgG 抗体阴性、HSV-1 IgG 抗体阳性患者的诊断应谨慎。②对于首次出现生殖器疱疹症状的患者,很难从临床上区分是既往疱疹感染的首次发作或是疱疹原发感染的首次发作。但由于疱疹原发感染首次发作时,HSV IgG 抗体往往检测阴性,因此可通过血液学检测进行区分。应对疱疹原发感染首次发作的患者进行随访,其血清抗体通常在 90 d 转阳。③通过检测明确生殖器疱疹患者的性伴侣是否感染,从而采取预防措施减少其感染。④对于没有临床症状的孕妇,如果其性伴侣患有生殖器疱疹,孕妇也应常规进行疱疹检测。HSV-1 和/或 HSV-2 抗体阴性的孕妇,在怀孕期间应避免感染 HSV。

1.3 血液学检测的其他注意事项 ①由于 HSV-1 和 HSV-2 抗体在疱疹感染早期可能尚未形成或滴度过低,因此在早期感染者中常出现假阴性结果,可通过重复实验或选用不同厂家试剂来进行确诊。②目前尚没有足够证据表明 HSV-2 会增加围产期 HIV 传播,因此不推荐对 HIV 阳性的孕妇常规进行疱疹检测。③由于非型特异性的 HSV 抗体检测在疱疹诊断中缺乏临床意义,因此应使用型特异性糖蛋白 gG1 和 gG2 的 HSV 血清学检测试剂。④虽然蛋白印迹是疱疹诊断的金标准,其敏感性 >97%、特异性 >98%,但由于操作复杂且无商品化产品,因此只在少数科研机构能够完成该检测。⑤不同品牌的血液学疱疹检测试剂在不同人群中的敏感性和特异性存在显著差异,因此在低发病率人群中难以准确分析出正确的阳性预测值(PPV)。此外,HSV 血清阳性率、感染生殖器疱疹的风险因素和患者的临床病史都会影响检测的 PPV,造成结果解释困难。⑥可以通过提高阳性参考值的界定范围或用另一种确诊试剂检测所有可疑样本,从而可提高 ELISA 检测的特异性。⑦不推荐将 IgM 作为临床常规诊断方法。⑧研究表明,由于 HSV 型别差异或检测方法的不同,12%~30% 的患者无法检测出 HSV 型特异性 IgG 抗体。

2 生殖器疱疹的临床管理

2.1 生殖器疱疹首次发作的临床管理 生殖器疱疹的首次发作通常比复发时的病程更长。如果不进

<http://pfbxzz.paperopen.com>

行治疗,大部分患者可能会出现全身和局部并发症。而及早治疗的疗效显著,因此对于临床可疑的生殖器疱疹首次发作的患者应尽早进行治疗。患者在出现症状的 5 d 内或仍有新皮疹形成时,应给予口服抗病毒药物。虽然阿昔洛韦、伐昔洛韦和泛昔洛韦均可有效减少发作的严重性和持续时间,但现有的治疗手段无法改变生殖器疱疹感染的自然病程。由于外用抗病毒药物效果低于口服药物,且易产生耐药性,因此不推荐使用外用抗病毒药物。只有在患者无法吞咽或口服药物出现呕吐的情况下才推荐使用静脉注射治疗。推荐治疗方案:阿昔洛韦 400 mg 口服,3 次/d;或阿昔洛韦 200 mg 口服,5 次/d;或泛昔洛韦 250 mg 口服,3 次/d;或伐昔洛韦 500 mg 口服,2 次/d;疗程 5~10 d。临床医生给出的治疗方案应考虑治疗费用和患者的依从性。部分患者的症状会持续 5 d 以上,因此如果只给予 5 d 的治疗方案,应建议患者尽早复查,以明确病变是否进展、出现全身症状或并发症,如有则需延长治疗时间。此外可以通过外用生理盐水冲洗患处并使用适当的止痛药来缓解患者局部症状。虽然局部麻醉剂容易出现过敏反应,但利多卡因凝胶或软膏不易致敏,因此可用于生殖器疱疹的局部治疗;而具有强烈致敏性的苯佐卡因不应在临床中使用。对于严重排尿困难的女性,可通过水中排尿(即将生殖器浸入水中)或将生理盐水沿阴唇缓慢倒下来缓解症状。医务人员对患者提供的临床建议应具有可行性并根据其个人情况进行调整,应告知患者:①无症状病毒脱落是疱疹传播的重要性;②安全套和抗病毒药物在减少疱疹传播的局限性;③疱疹流行率高但发病率低的特点;④男女双方孕期的注意事项;⑤精神压力过大很容易诱发生殖器疱疹的持续复发;⑥很难预测患者需要一个或两个疗程的治疗,因此对于 3~6 个月内症状改善不明显的患者,密切随访非常重要。当患者出现尿潴留、脑膜炎、严重全身症状时,建议患者住院治疗。如需要进行插管治疗,耻骨上经膀胱途径可更好地控制患者的症状。临床上双重感染罕见,通常发生在第 2 周,是局部症状复发的特征,最常继发念珠菌感染。理论上,生殖器 HSV 感染与特应性皮炎的双重感染、复发性疱疹样湿疹或复发性多形红斑相关。部分病例报告口周 HSV-1 感染也可引发相同的并发症。目前尚缺乏对 HIV 阳性患

者生殖器疱疹首次发作治疗持续时间和剂量的临床对照研究数据。部分临床医师建议给予 2 倍标准剂量治疗 10 d。医务人员应与生殖器疱疹首次发作患者探讨以下内容:①感染进程,包括无症状病毒脱落;②治疗选择;③传播风险及干预措施;④感染新生儿的危险,并建议患者将患病情况告知产科医生或助产士;⑤性伴通知感染的可能性及可能存在的感染源;⑥在一夫一妻的关系中,多年没有症状的性伴侣仍具有传染性。治疗后的随访应持续到治疗结束或患者咨询完成。若存在其他导致生殖器溃疡的原因,应进一步排除。如有复发,应建议患者复诊。

2.2 复发性生殖器疱疹发作期的临床管理 复发性生殖器疱疹为自限性疾病,一般引起轻微的症状。其对患者性生活及社会活动造成的困扰程度通常与复发频率无关。应与患者探讨并制定减少疱疹复发的最佳方案。治疗方案包括单纯支持治疗、发作期抗病毒治疗和抗病毒抑制疗法。对个体最合适的治疗方案可能随着复发频率、症状严重程度及医患关系的变化而变化。对于大部分患者来说,只需采取简单局部处理(如盐水浴或外用凡士林)的单纯性支持治疗即可。口服阿昔洛韦、伐昔洛韦和泛昔洛韦可有效减少复发性生殖器疱疹的持续时间和严重程度,疱疹持续时间平均可减少 1~2 d。平行对照研究显示,不存在哪一种疗法优于其他疗法,或者超过 5 d 的疗法优于超短程疗法。前体药物只需 2 次/d 给药。患者在症状出现 24 h 内开始治疗的疗效最佳,及早治疗可使近 1/3 的患者不出现皮疹。为确保患者及时治疗,应建议患者随身携带少量药物。推荐治疗方案首选短程疗法:阿昔洛韦 800 mg 口服,3 次/d,共 2 d;或泛昔洛韦 1 g 口服,2 次/d,共 1 d;或伐昔洛韦 500 mg 口服,2 次/d,共 3 d。长达 5 d 的替代疗法:阿昔洛韦 400 mg 口服,3 次/d,连续 3~5 d;或阿昔洛韦 200 mg 口服,5 次/d;或伐昔洛韦 500 mg 口服,2 次/d;或泛昔洛韦 125 mg 口服,2 次/d。

2.3 复发性生殖器疱疹频繁复发的抑制疗法 大多数早期研究采用的抑制疗法是针对每年复发 ≥ 6 次的患者。近期已完成的研究主要针对症状轻微的患者。研究表明,抑制疗法可减少不同程度疱疹患者的复发率。对于频繁复发者是否采用抑制疗法需要基于其疱疹复发的频率、疾病对个体的影响、减少传播风险的需求、治疗成本和不便性等因素进行综

<http://pfbxzz.paperopen.com>

合考量。虽然抑制疗法可显著降低患者复发频率,然而使用此疗法的大部分患者仍偶尔会出现复发病状。治疗期间患者复发情况可能会出现变化,谨慎起见,需定期评估是否继续治疗。即使经过长时间的抑制疗法,许多患者在停止治疗后,其复发频率与疾病严重程度未见显著改变。患者每年应至少进行一次评估是否有必要继续进行抑制疗法,若患者同意停止治疗,应对其复发频率进行重新评估。与治疗前相比,少数患者的复发频率降低。应对停止治疗的患者根据其复发频率和严重程度进行评估,最少进行 2 次评估。对频繁复发患者重新进行治疗是安全且合理的。短期抑制疗法对于需要考试、度假等患者预防复发有帮助。临床医生需要知道抑制疗法通常在治疗 5 d 后见效。推荐治疗方案:阿昔洛韦 400 mg 口服,2 次/d(适用于不同复发频率的患者);或伐昔洛韦 500 mg 口服,1 次/d(适用于每年复发少于 10 次的患者);或伐昔洛韦 1 g 口服,1 次/d(适用于每年复发大于 10 次的患者)。采用标准治疗剂量不需要常规进行血液检测。采用阿昔洛韦作为抗病毒抑制疗法的研究最广,在长期治疗中,阿昔洛韦的安全性和耐药性数据监测已超过 18 年,长期使用不会引起毒素累积或器官损伤,仅在严重肾病患者中需调整治疗剂量。在患者其他方面都良好的情况下,不建议定期进行血液检测。伐昔洛韦治疗期间,偶见患者出现轻度头痛或恶心。阿昔洛韦最佳抑制剂量为 800 mg/d,阿昔洛韦 200 mg/次口服、4 次/d 的服药方式比 400 mg/次口服、2 次/d 的疗效更佳($P < 0.02$);然而应考虑患者是否能执行 4 次/d 的用药方案。伐昔洛韦 250 mg/次口服、2 次/d 的疗效与阿昔洛韦 400 mg/次口服、2 次/d 的疗效一致。阿昔洛韦 1 次/d 的疗法无法抑制生殖器疱疹复发。对于伐昔洛韦单次口服是否与 2 次/d 同样有效存在一定争议。伐昔洛韦 500 mg 单次口服给药可满足每年复发小于 10 次的患者;伐昔洛韦 250 mg/次口服、2 次/d 或者每次 1 g 单次口服适用于每年复发大于 10 次的患者。在临床治疗中,采用伐昔洛韦 500 mg/d 单次口服和泛昔洛韦 250 mg/次口服、2 次/d 的抑制疗法没有显著差异。对于疗效不佳的患者,伐昔洛韦或泛昔洛韦每日治疗剂量需要加倍。疗效不佳的治疗方案:阿昔洛韦 400 mg 口服,3 次/d;或伐昔洛韦 250 mg 口服,2 次/d;或伐昔

洛韦 500 mg 口服,2 次/d;或阿昔洛韦 200 mg 口服,4 次/d。大部分疱疹患者会出现无症状生殖器 HSV-1 和/或 HSV-2 病毒脱落,HSV-2 感染者感染后的第 1 年或频繁复发的患者更易出现病毒脱落。阿昔洛韦、伐昔洛韦和泛昔洛韦都可抑制有症状和无症状病毒脱落。虽然在生物学上看似合理,但局部抑制病毒脱落无法减少 HSV 传播。500 mg/d 伐昔洛韦(每年复发 ≤ 10 次)的抑制疗法可显著降低(接近 50%)HSV 感染性伴侣。阿昔洛韦 400 mg/次口服、2 次/d 可达到同样效果。除了使用安全套和禁欲外,还可增加抗病毒抑制疗法来减少 HSV 传播。

3 免疫功能低下或 HIV 阳性的疱疹患者的临床管理

在流行病学上,HSV 与 HIV 感染存在协同作用。HSV 感染会激活 HIV 的复制,并可能促进 HIV 向性伴侣传播。使用伐昔洛韦对 HSV-2 进行抑制性治疗,可以减少未服用抗 HIV 病毒药物女性生殖器部位的 HIV 病毒脱落。HSV-2 的流行和发病都会增加 HIV 感染风险。生殖器疱疹自然史在未经治疗的 HIV 感染者和 HIV 阴性个体之间存在显著差异,HIV 免疫抑制程度是激活疱疹最重要的危险因素。用于治疗 HIV 阴性生殖器疱疹患者的标准抗病毒药物,对于未经治疗的 HIV 感染者同样有效。但 HIV 合并感染者更容易对抗疱疹药物产生耐药,并导致生殖器疱疹治疗失败。多项研究显示,现有的抗疱疹病毒抑制疗法对 HIV 感染的获得或传播风险没有影响。因此不推荐采用该疗法来用于治疗或减少 HIV 感染或传播。大部分关于 HIV 感染者的疱疹治疗研究数据来自联合抗逆转录病毒疗法之前。早期流行病学的前瞻性研究显示,HIV 感染者的临床症状更持久和严重。生殖器疱疹(包括慢性侵蚀性病变)可能作为免疫重建炎症综合征(IRIS)的一种表现形式,出现在联合抗逆转录病毒治疗后。即使不存在耐药,在不增加抗病毒药物的情况下,HSV 伴 IRIS 可能对前期有效的抗疱疹病毒疗法没有反应。尽管治疗困难,但外用西多福韦可能有效。

3.1 生殖器疱疹首次发作的临床管理 目前还没有 HIV 感染者的生殖器疱疹首次发作的抗病毒治疗试验数据,因为绝大部分 HIV 感染者都伴有

<http://pfbxzz.paperopen.com>

HSV-1 和 HSV-2 血清抗体阳性,导致试验设计困难。案例研究显示,生殖器 HSV 的感染可能与长期、不确定的临床病程有关。如果皮肤没有出现免疫清除,那么可能会发生全身症状,并可能形成慢性病变。未治疗的 HIV 患者,原发性生殖器疱疹症状将更严重、病程更长,可伴有进行性、多灶性以及合并皮肤黏膜肛门生殖器病变的风险。此外,目前已有潜在的严重危及生命的系统性并发症报道(如暴发性肝炎、肺气肿、神经系统疾病和播散性感染)。在缺乏临床数据的情况下,对患有免疫功能低下的生殖器疱疹初发感染的治疗,大部分权威指南建议数倍标准治疗方案。但对于 CD4 细胞总数正常的 HIV 患者,可能并不需要数倍治疗方案。在晚期 HIV 感染者中,应考虑是否需要双倍标准抗病毒剂量治疗。如果在第 3~5 d 仍有新的皮疹继续形成,应考虑给予更高的抗病毒剂量,建议及早开始治疗;如果在第 3~5 d 后仍形成新的皮疹,应开展病毒分离和药敏试验,与此同时,HSV 治疗剂量也应增加。推荐治疗方案:阿昔洛韦 400 mg 口服,5 次/d,7~10 d;或伐昔洛韦 500~1 000 mg 口服,2 次/d,10 d;或泛昔洛韦 250~500 mg 口服,3 次/d,10 d。全部治疗方案应至少持续 10 d,或者直到所有病变愈合为止(通常会超过 10 d)。如果继发爆发性疱疹,则静脉内注射阿昔洛韦每 8 h 用药 5~10 mg/kg,持续 2~7 d 或直到临床症状改善,随后给予口服抗病毒药物治疗,总治疗过程至少持续 10 d。

3.2 复发性生殖器疱疹发作期的临床管理 HIV 感染者(尤其是 CD4 细胞数 < 50 个/mm³)更频繁出现生殖器疱疹临床和亚临床复发,并可导致持续进展的肛门生殖器黏膜皮损,这些皮损缺乏特异性,可出现较大、较深和肥厚性病变。联合抗逆转录病毒治疗来优化对 HIV 病毒复制的控制对于复发性生殖器疱疹的治疗至关重要。高效抗逆转录病毒疗法(HAART)可减少临床复发频率,但对无症状病毒脱落的疗效不佳;因此特定的抗病毒药物可用于发作期或抑制疗法。免疫功能低下患者的抗病毒治疗临床研究正受到极大关注。对于大部分患者来说,5 d 疗程已足够。值得注意的是,HIV 晚期患者中有 13%~17% 的病人在接受为期 7 d 的治疗后,会出现新的皮损。一项针对泛昔洛韦试验的研究证实,对于 CD4 细胞数良好者(> 500 个/mm³),采用短期

治疗可能已足够。在没有免疫缺陷的患者中,采用标准剂量抗病毒药物是足够的。对于晚期 HIV 的患者,可能需要将标准剂量加倍,并持续治疗 5 d 以上。在临床中应谨慎使用极短期疗程,因为这些治疗方案在免疫功能不全患者中尚未得到充分评估。

3.3 复发性生殖器疱疹频繁复发的抑制疗法 使用抑制性抗病毒方法治疗疱疹时,其在 HIV 阴性患者中的效果优于 HIV 感染者,但 HIV 感染者对该治疗方案的耐受性良好。阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦的疗效都经过临床验证。阿昔洛韦标准抑制疗法的疗效确切。伐昔洛韦 500 mg/次口服、2 次/d 的方案优于 1 g/d 单次口服方案。尚未在 HIV 阳性患者中评估伐昔洛韦每日单次 500 mg 的疗效。目前仅有高剂量泛昔洛韦短期疗程的试验数据。对能够充分抑制 HIV 复制且 CD4 细胞数高的患者,在生殖器疱疹治疗中,建议采用间歇性抑制疗法。对 HIV 未治疗的患者,如果生殖器疱疹发作频率较低,可采用发作期治疗方案。对于之前采用抑制疗法治疗的患者,如果疱疹仍然继续复发,需要重新开始抑制疗法。已有大量人体试验数据证实,在 HIV 阳性免疫功能不全的患者中,口服抗病毒药物的安全性。在 HAART 时期前,有两项研究针对高剂量阿昔洛韦(口服 400 mg/次、4 次/d)安全性进行评估。近年来,更多研究则采用标准治疗方案对其安全进行评估。对伐昔洛韦的研究重点是观察其抑制生殖器疱疹复发的价值。高剂量伐昔洛韦(口服 2 g/次、4 次/d)在 HIV 阳性、免疫抑制以及骨髓移植后的患者中的应用已被证实。近期有大量的研究证实阿昔洛韦和伐昔洛韦在抑制疗法中的有效性,及对共染者 HIV 传播的影响。这些实验表明,与 HIV 阴性患者相比,使用阿昔洛韦标准剂量口服以及伐昔洛韦 1 g/d 单次口服或 500 mg/次口服、2 次/d 的方案,对 HIV 感染者几乎没有不良反应和毒性产生。高剂量伐昔洛韦(8 g/d 口服)与微血管病性溶血-尿毒症综合征相关。推荐治疗方案:阿昔洛韦 400 mg 口服,2~3 次/d;或伐昔洛韦 500 mg 口服,2 次/d。如果以上治疗方案不能充分控制症状,首选方案是加倍治疗剂量。如果之后仍然不能控制症状,可尝试泛昔洛韦 500 mg 口服,2 次/d。患者进行 HIV 病毒载量检测时发现,使用抑制性抗病毒治疗方案(阿昔洛韦或伐昔洛韦)可以降低患者血液中 HIV 病毒水平,

<http://pfbxzz.paperopen.com>

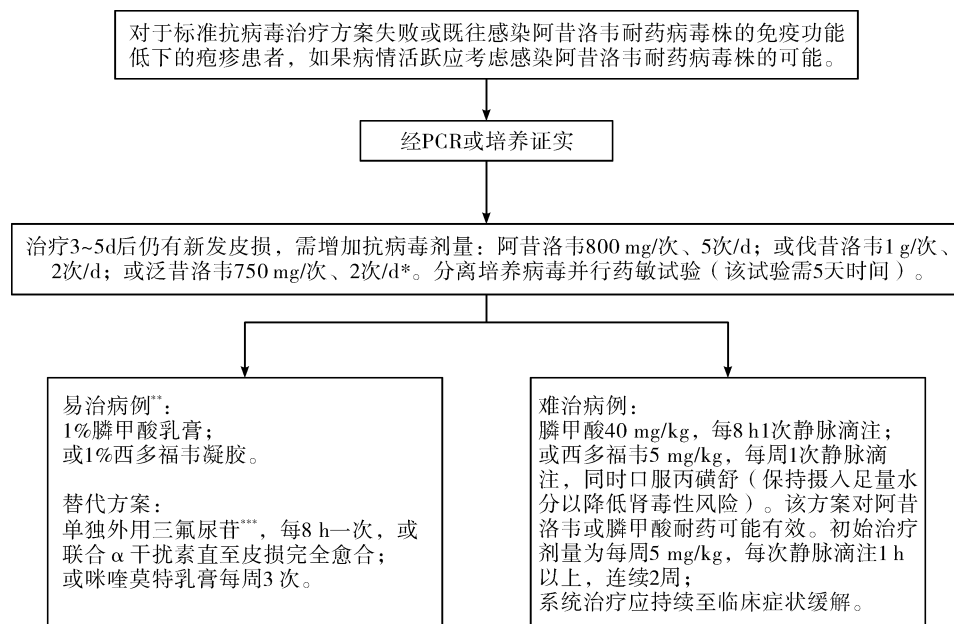
但该机制目前尚未完全明确。该治疗策略将影响 HIV 的进程,特别是无法使用 HAART 的个体。针对早期 HIV 感染者(即尚未采用 HAART 且 CD4 超过 250 个/mm³)的大量随机对照研究已经表明,标准剂量(阿昔洛韦 400 mg 口服、2 次/d)的抑制性抗病毒治疗将使 CD4 细胞数维持在 250 个/mm³ 以上,因此使得治疗组 2 年内 HAART 需求减少了 16%。然而,在应用 HAART 的患者中,使用抑制性抗病毒药物是否存在好处,目前尚不清楚。

3.4 耐药性疱疹的临床管理 虽然生殖器疱疹引起的临床难治性皮损并不常见,但在严重免疫缺陷患者(如晚期 HIV 感染者、IRIS 联合抗逆转录病毒治疗者)中却是一个主要难题。在此情况下治疗方案如图 1 所示。对耐药性疱疹的 HIV 感染者,通常首选膦甲酸或西多福韦系统性治疗方案。有证据表明,在后续复发治疗中,用阿昔洛韦和西多福韦治疗可能会减少西多福韦耐药菌株的形成。然而,这些药物治疗反应的有效性、安全性和持久性,在前瞻性对照试验中尚待明确。在一些前瞻性研究中发现,约 5%~7% HIV 感染者的疱疹皮损中可分离出阿昔洛韦耐药株。如果分离到的 HSV 需要浓度 >1~3 mg/L 的阿昔洛韦才能抑制,则可明确为阿昔洛韦耐药。阿昔洛韦耐药常由 HSV 胸苷激酶(TK)基因

编码突变导致其对阿昔洛韦黏附力降低或无法合成。TK 主要作用于阿昔洛韦初始磷酸化成活化形式。TK 缺陷型菌株对免疫功能正常的患者致病性低,但在严重免疫缺陷的患者中可引起严重的局部和全身性症状。生殖器疱疹在潜伏期的发展可能与 TK 缺陷型菌株无关,因此临床后期生殖器疱疹重新激活常由阿昔洛韦敏感的病毒株引起。对部分耐药的菌株可以采用静脉注射高剂量阿昔洛韦和其他核苷类似物;但对于完全耐药的菌株会对伐昔洛韦、更昔洛韦产生耐药性,大部分对泛昔洛韦产生耐药性。膦甲酸和西多福韦对 TK 缺陷型菌株治疗有效,因为二者不依赖于 TK,而抑制病毒 DNA 聚合酶。在 HSV 治疗中,抗病毒药物的耐药性检测的作用有限,因此在临床上常以抗病毒药物的治疗反应作为治疗参考。若怀疑出现临床耐药,应向病毒专家咨询治疗方案的药物剂量和治疗持续时间。

4 孕妇生殖器疱疹的临床管理

4.1 生殖器疱疹首次发作的临床管理 ①妊娠早期与中期:应根据孕妇的临床表现给予相应治疗,通常给予口服或静脉注射标准剂量的阿昔洛韦。假如孕妇尚未分娩,应给予治疗,后期可经阴道分娩。从妊娠第 36 周起,阿昔洛韦 400 mg/次口服、3 次/d 进行抑制性治疗,可预防足月分娩时 HSV 皮损的出



* 对阿昔洛韦耐药株同样对伐昔洛韦耐药; ** 易治病例可采用局部治疗方案; *** 目前缺乏商品化产品, 需要医院自制

图 1 免疫功能不全患者疱疹治疗流程图

Fig. 1 Algorithm for the treatment of herpes in immunocompromised individuals

现及剖腹产的需要; ②妊娠晚期: 因为分娩时病毒脱落风险非常高, 所有孕妇(尤其是距分娩 6 周内出现症状者) 均考虑剖腹产, 阿昔洛韦 400 mg/次口服、3 次/d 进行抑制性治疗应持续至分娩。如果必须进行阴道分娩, 应避免长时间的破膜和侵入性手术(如使用头皮电极)。分娩后应考虑是否给予母亲和婴儿静脉注射阿昔洛韦, 并告知儿科医生。

4.2 复发性生殖器疱疹的临床管理 当妇女有复发性生殖器疱疹时, 应告知其新生儿患疱疹的风险非常低。①妊娠早期与中期: 虽然妊娠早期和中期服用阿昔洛韦的安全性尚未完全证实, 但审慎的采用该药物治疗疱疹复发已得到广泛认可。妊娠早期不推荐采用连续性或间歇性治疗。对于严重和复杂患者的治疗应逐案评估, 并避免使用较新的抗病毒药物, 且将阿昔洛韦的治疗剂量维持最低有效水平。②妊娠晚期: 妊娠晚期生殖器疱疹复发病状持续时间较短。若在分娩时没有出现皮损则可采用阴道分娩, 若孕妇有复发性生殖器疱疹病史, 且在分娩时有皮损, 可选择剖腹产。从妊娠第 36 周起, 阿昔洛韦 400 mg/次口服、3 次/d 进行抑制性治疗, 可预防足月分娩时疱疹皮损的出现及剖腹产的需要。若孕妇分娩时未出现生殖器疱疹皮损, 则没有必要采用剖腹产来预防新生儿疱疹, 没有必要在妊娠后期通过连续病毒培养或 PCR 检测来预测分娩时病毒脱落情况。为了识别孕妇分娩时是否存在无症状病毒脱落而采用病毒培养或 PCR 检测的实用性未经证实。③分娩时: 分娩开始时, 若存在复发性生殖器疱疹皮损, 应考虑剖腹产。通过阴道分娩引起新生儿疱疹风险很小, 因此必须评估剖腹产对孕妇所存在的风险。来自荷兰的证据表明, 通过保守方法, 即存在复发性生殖器皮损的情况下进行阴道分娩, 新生儿疱疹病例数并没有增加。但只有在获得产科医生和儿科医师的全力支持, 且符合当地医疗法规的情况下, 才能采取这种分娩方式。分娩时生殖器疱疹的临床诊断与通过培养或 PCR 检测生殖器部位 HSV 的相关性较差, 且无法鉴别是否具有无症状病毒脱落。目前尚无任何用于妊娠疱疹的抗病毒药物获得许可, 但怀孕期间使用阿昔洛韦除了导致短暂性中性粒细胞减少之外, 还未发现其与孕期、胎儿或新生儿不良反应相关。由于伐昔洛韦是阿昔洛韦的缬氨酸酯, 因此从阿昔洛韦的安全性数据可推测伐昔洛韦

在妊娠晚期的使用也可能是安全的, 但目前伐昔洛韦用药经验较少。临床中应避免使用泛昔洛韦。④HIV 阳性: 部分证据表明, HIV 感染的孕妇若伴有溃疡性生殖器疱疹, 则更易传播 HIV, 且传播过程不会受到其他因素影响。然而, 该研究结果在学界还未达成共识。HIV 抗体阳性且有生殖器疱疹病史的孕妇, 应从怀孕第 32 周开始, 应用阿昔洛韦 400 mg/次口服、3 次/d, 此治疗方案可以降低 HIV-1 传播风险。若计划经阴道分娩, 更应考虑以上治疗方案。考虑到存在早产的可能性, 应跟孕妇探讨是否在妊娠早期就开始治疗。目前尚无推荐的抑制性治疗方案用于 HIV-1 抗体阳性且 HSV-1/2 型血清阳性但没有生殖器疱疹史的孕妇。

4.3 HSV 感染的预防 母亲感染疱疹病毒的风险因地区而异, 当地流行病学调查可协助疱疹预防指南策略的制定。所有预防新生儿疱疹的方案都需要父母双方共同参与。对所有第 1 次产前检查的孕妇, 都应询问其本人及性伴侣是否患有生殖器或口腔疱疹。患有生殖器疱疹的男性, 如果其女性伴侣没有生殖器疱疹病史, 应告知其如何降低妊娠期间被传染疱疹的风险以及在孕期传染给胎儿或新生儿的危险。避免被感染的方法包括选择性或完全禁欲(特别是在妊娠晚期), 以及认真负责地使用安全套。研究表明通过每天抑制性治疗可以显著降低疱疹患者向血清阴性性伴侣传播 HSV 的风险; 但男性的抑制性治疗是否可以减少孕妇被传染的几率目前尚不清楚, 因此建议对孕期性行为保持谨慎。应告知孕妇在妊娠期间(特别是在妊娠晚期) 被动口交(即被动接受口-生殖器接触) 会增加感染 HSV-1 的风险。通过特异性抗体检测来识别易感女性的方法尚未显示出成本效益, 除非既往病史表明性伴侣间存在血清学不一致, 否则此检测方法不会在欧洲应用。不仅是有生殖器疱疹病史的女性, 所有女性都应该在开始分娩时仔细检查外阴, 来明确是否有疱疹感染的临床症状。母亲、医务人员、亲属和朋友等出现口腔活动性疱疹或疱疹性瘰疬, 都应避免其皮损与新生儿直接接触。

5 新生儿生殖器疱疹的临床管理

5.1 母亲分娩时出现生殖器疱疹首次发作的新生儿临床管理 应请儿科医生会诊。从尿液、粪便、口咽、眼等处取材进行 HSV PCR 检测, 以明确新生儿

<http://pfbxzz.paperopen.com>

是否感染疱疹。如果无法立刻得到实验结果,应考虑开始静脉滴注阿昔洛韦的益处和风险。若没有立即用阿昔洛韦进行治疗,则应密切监测新生儿是否存在嗜睡、发热、食欲不振或其他病变。

5.2 母亲分娩时出现生殖器疱疹复发的新生儿临床管理 一些临床医生认为在分娩后 24 ~ 48 h 内采集新生儿样本进行 PCR 检测可能有助于早期识别疱疹感染,但尚未有依据支持此方法。若新生儿出现任何感染迹象或出现皮肤、眼睛或黏膜损伤,尤其是在出生后前 2 周,医护人员和家长应在鉴别诊断中考虑 HSV 感染的可能性。

6 性伴管理

目前性伴通知的处理流程还未完善。基于其个人意愿,可向其性伴侣提供咨询帮助。向患者性伴侣提供咨询时应注意以下几点: ①推荐使用避孕套,特别是存在性传播的可能性,即使患者在抑制性抗病毒治疗的情况下也应使用避孕套; ②无症状病毒脱落落在 HSV 传播中起着重要作用,因此选择性禁欲(即出现症状或表现才禁欲)并不是控制 HSV 传播的有效策略; ③对未感染或无症状的性伴侣可采用型特异性抗体检测法进行血液学检测; ④咨询后,高达 50% 的无症状 HSV-2 阳性的女性患者可以学会识别生殖器疱疹的复发; ⑤通过抑制性抗病毒治疗或使用安全套可以减少病毒传播。

7 译者点评

2017 版欧洲生殖器疱疹治疗指南^[1]与 2010 版欧洲生殖器疱疹治疗指南相比,有以下更新: ①认识方面: 由于 HSV 可出现无症状病毒脱落,因此患者在无皮损时仍具有传染性; HSV 伴 HIV 感染更易出现危及生命的系统性并发症如暴发性肝炎、肺气肿、神经系统疾病和播散性感染等; 阿昔洛韦安全性高,采用标准治疗剂量不需常规进行血液检测; 12% ~ 30% 疱疹患者 HSV 型特异性 IgG 抗体检测阴性; HIV 的免疫抑制是激活疱疹复发最主要的危险因素; HSV 伴 HIV 感染更易出现抗疱疹药物耐药; 使

用抑制疗法可以降低 HIV 感染者血液中 HIV 病毒水平; TK 缺陷型菌株对免疫功能正常者的致病性低。②实验室方面: HSV DNA 检测的敏感性和特异性高于细胞培养法,是疱疹诊断金标准,推荐作为首选检测方法; 荧光定量 PCR 法可快速对 HSV 进行检测和分型,且实验室污染风险更低; 不再推荐直接免疫荧光、酶联免疫、Tzanck 和巴氏染色等 HSV 抗原检测方法; 不建议对无症状患者采用血液学和 HSV DNA 检测; 不推荐 HSV IgM 检测方法; 5% ~ 7% HIV 感染者疱疹皮损中可分离出阿昔洛韦耐药株; 可从尿液、粪便、口咽、眼等处取材行 HSV PCR 检测,用以明确新生儿疱疹感染。③治疗方面: 因外用抗病毒药物疗效低于口服药物,且易诱导耐药,不推荐使用外用抗病毒药物; 复发性疱疹推荐采用短程疗法; 抗病毒药物的多次给药疗效优于单次给药; 所有 HIV 阳性的初发疱疹患者,总疗程至少持续 10 d; HSV 伴 IRIS 往往对抗疱疹病毒药物无效; 8 g/d 高剂量伐昔洛韦与微血管病性溶血-尿毒症综合征相关; HIV 感染者出现疱疹耐药首选膦甲酸或西多福韦。④预防方面: 安全套可以减少 HSV 传播,但确切预防效能不明; 性伴侣患有疱疹的无症状孕妇,建议常规进行疱疹抗体检测; 500 mg/d 伐昔洛韦或 800 mg 阿昔洛韦的抑制疗法可降低约 50% 性伴侣感染 HSV; 选择性禁欲(即出现疱疹症状才禁欲)无法减少 HSV 传播; 妊娠 36 周起口服阿昔洛韦可预防足月分娩时疱疹皮损的出现及剖宫产的需要; 避免妊娠期间(特别是在妊娠晚期)被动口交,可减少 HSV-1 感染的风险; 出现口腔活动性疱疹或疱疹性瘰疬时,应避免皮损接触新生儿。

参 考 文 献

- [1] Rajul P, Oliver K, Emily C, et al. 2017 European guidelines for the management of genital herpes [J]. Int J STD AIDS, 2017, 28(14): 1366-1379.

收稿日期 2018-05-28 修回日期 2018-07-06